

УДК: 616.628-006.6: 615.849

В.Б.Ким, Е.И.Ишкинин, М.А.Ибраимова, Я.С.Мальшиева, О.Ю.Трущенко, Р.Г.Панов, Р.Б.Раимбеков, А.Сарсембаев, Р.Отынышев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Применение препарата Пентаса при лучевой терапии у пациентов с опухолями малого таза

Аннотация. Вопрос улучшения качества жизни и лечения пациентам при лучевой терапии становится все более актуальным. Проведено рандомизированное исследование у 40 пациентов, основная группа – препаратом Пентаса, контрольная группа – стандартная протекторная терапия. В группе получавших пентасу выраженность лучевых реакции со стороны кишечника была ниже, не зафиксированы дополнительные побочные эффекты. У 13 пациентов основной группы (65%) и у 18 пациентов контрольной группы (95%) были зафиксированы проявления токсического поражения кишечника в различной степени. Относительный риск (RR) составил 0,72 95% ДИ (от 0,5 до 1,03); отношение шансов – 0,21 95% ДИ (от 0,04 до 1,16); снижение абсолютного риска развития кишечных осложнений на 0,25 при приеме препарата Пентаса.

Ключевые слова: лучевая терапия, качество жизни, опухоли малого таза,

Крона, хронических колитов другого происхождения. Выраженный противовоспалительный эффект препарата Пентаса обусловлен подавлением выброса лейкотриена В₄, блокированием липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты, уменьшением воспаления. Дополнительным механизмом действия месалазина является разрушение свободных радикалов и угнетение продукции интерлейкина 1 β . Большим отличием от аналогичных препаратов группы месалазина является pH независимая оболочка, позволяющая высвобождаться 5 АСК уже в желудке и высокая эффективность даже при повышенной моторике кишечника. Вопрос улучшения качества жизни и лечения пациентов, которым назначена лучевая терапия становится все более актуальным.

Цель исследования

Уменьшение токсических проявлений со стороны кишечника у пациентов, получающих лучевую терапию.

Актуальность

Лучевая терапия органов малого таза, почти всегда приводит к развитию острого дозо-зависимого поражения любого отдела кишечника в течение всего периода лечения. В основном, поражения развиваются с 2-3 недели после начала облучения и имеют свои специфические осложнения: энтериты, колиты, ректальные кровотечения, провоцирует обострения хронического проктосигмоидита, хронического геморроя, увеличивает риск развития кишечной непроходимости. Поражаются, как правило, все слои кишечной стенки, включая серозную оболочку. При морфологическом исследовании выявляют участки гиалиноза в собственной пластинке слизистой, облитерирующий эндартериит в подслизистом слое со скоплением фибробластов. Эти изменения приводят к развитию относительной ишемии или тканевой гипоксии, что проявляется утолщением серозной оболочки, развитием фиброза мышечного слоя и утолщением слизистой оболочки стенки кишки, а также атрофией и изъязвлением слизистой оболочки. Эпителий тонкой и толстой кишок особенно восприимчив к острому лучевому поражению. Для улучшения результатов лечения и уменьшения частоты и выраженности лучевых осложнений проводятся различные защитные лечебные мероприятия (микроклизмы, витаминотерапия и др.). Однако эффективность этой терапии различна, сведения разрозненны, не разработаны четкие рекомендации касательно доз и продолжительности курса протекторной терапии. Действующее вещество препарата Пентаса хорошо известный в гастроэнтерологической практике месалазин, который с успехом применяется в лечении неспецифического язвенного колита, болезни

Материалы и методы

Было проведено рандомизированное исследование у 40 пациентов с опухолями малого таза, у которых в зону облучения попадал кишечник. Им была проведена лучевая терапия (ЛТ) в отделении радиационной онкологии Казахского НИИ онкологии и радиологии за период с января по сентябрь 2013г. Больные были распределены в 2 группы по 20 пациентов конвертным методом односторонней рандомизации. Пациенты основной группы с первого сеанса облучения получали препарат Пентаса фармацевтической компании Ferring (Швейцария) в стандартной дозировке 1 таблетка (500 мг) 3 раза в день. Пациентам контрольной группы, проводилась стандартная симптоматическая, протекторная терапия. Возраст пациентов на момент лечения составил от 31 до 68 лет, медиана 55,1 год, 24 мужчин и 16 женщин. Было проведено стандартное клинко-рентгенологическое обследование: УЗИ органов малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства, Облучение пациентов проводилось на линейном ускорителе Clinac 2100 C/D с применением MLC. Разовая очаговая доза (РОД) составила 2,5 Гр 5 Фр в неделю до суммарной очаговой дозы (СОД) 40 Гр. Пациентам была проведена предлучевая топометрическая подготовка на рентгеновском симуляторе AcuityCBCT, КТ-топометрия на 64 срезном КТ VCTLightSpeedGE, подбор индивидуального режима радиотерапии, общий объем оконтуренного кишечника составил от 134 до 216 см³, медиана составила 160см³. По результатам индивидуального дозиметрического планирования на дозиметрической системе планирования ECLIPSE, 50% объема кишечника получил в среднем у пролеченных пациентов 89% дозы облучения. Создание базы данных осуществлялось в

программе Microsoft Excel. Статистическая обработка материала производилась на персональном компьютере при помощи программы математической обработки данных SPSS Statistics версия 19.0. Сравнение групп проводилось с помощью U-теста Манна-Уитни.

Результаты

На момент поступления у всех 40 пациентов не отмечался синдром интоксикации или раздраженного кишечника. Побочные эффекты являлись в основном преходящими, купирующимися в течении нескольких дней, включающих в себя: усиление боли в течении 12 часов (вследствие отека), симптомы, возникновение которых обусловлено зоной облучения: тошнота, (особенно при больших полях облучения позвоночника), диарея, раздражение кишечника, ректит. При контрольном осмотре через 2 недели у всех 40 пациентов отмечалось уменьшение интенсивности реакций со стороны кишечника. В группе пациентов получавших пентасу, выраженность ранних лучевых реакции со стороны кишечника была ниже, чем в контрольной группе. При сравнении результатов групп с помощью U-теста Манна-Уитни, несмотря на малое количество пациентов в группах, полученные результаты исследования статистически достоверны для 95% доверительного интервала, $\chi^2=3,584$, $p\text{-value}=0,029$. У 13 пациентов основной группы (65%) и у 18 пациентов контрольной группы (95%) были зафиксированы проявления токсического поражения кишечника в различной степени. Относительный риск (RR) составил 0,72 95% ДИ (от 0,5 до 1,03); отношение шансов – 0,21 95% ДИ (от 0,04 до 1,16); снижение абсолютного риска развития кишечных осложнений 0,25 при приеме препарата пентаса, таким образом, по сравнению со стандартным лечением, чтобы предотвратить развитие кишечных проявлений у одного пациента, нужно пролечить 4 пациента препаратом пентаса. Степень проявлений со стороны кишечника оценивалась по шкале RTOG: в основной группе у 9 пациентов - 1 балл, у 4 пациентов 2 балла. В контрольной группе у 12 пациентов - 1 балл, у 6 пациентов - 2 балла. Явления раздраженного кишечника, появились в среднем на 8,2 сеанс облучения в основной группе и 9,6 в контрольной (от 4 до 13 сеанс). Явления были купированы на 5-13 день после окончания лучевой терапии (в среднем на 8,8 день в основной группе и 10,5 день в контрольной). При приеме пентасы не зафиксированы дополнительные побочные эффекты (головная боль, рвота, тошнота, лихорадка, боль в брюшной полости и т. д.), однако эту закономерность необходимо проверить на большем числе наблюдений.

Выводы

Задачей лучевого лечения является доставка в зону облучения предписанную дозу и уменьшение выраженности побочных реакций. С использованием препарата пентаса нам удалось достичь этой цели. Предварительные результаты исследования показали высокую клиническую эффективность предлагаемого режима лечения, детальное изучение которого необходимо в дальнейших исследованиях.

Список литературы

- 1 Клинические рекомендации. - ESTRO-2012
- 2 Resbeut M. et al. A randomized double blind placebo controlled multicenter study of mesalazine for the prevention of acute radiation

enteritis. Centre de Recherche et de Lutte Contre le Cancer, Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France. PMID: 9288859 [PubMed - indexed for MEDLINE]

3 Baughan C.A. et al. A randomized trial to assess the efficacy of 5-aminosalicylic acid for the prevention of radiation enteritis // Wessex Radiotherapy Centre, Royal South Hants Hospital, Southampton, UK. PMID: 8424910 [PubMed - indexed for MEDLINE]

4 Layer P.H., Goebell H. et al. //Gastroenterology.-1995.-Vol. 108, N5.-P. 1427-1433.

5 Rasmussen S. et al. //Gastroenterology.-1982.-Vol. 83, №5.-P. 1062-1070.

6 Rijk M.C.M., Schaik Van A. et al. // Oxford Journals Gastroenterology.-2009.-№3.

Тұжырым

В.Б.Ким, Е.И. Ишкинин, М.А.Ибраимова, Я.С.Малышева, О.Ю.Трущенко, Р.Г.Панов

Қазатың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Кіші жамбас қуысы ісіктері бар науқастарда сәулелік ем кезіндегі пентас препаратын қолданылуы

Өмір сапасын жақсарту және сәулелік ем алатын науқастарда арнайы ем қолданылу өзекті мәселе болып табылады. 40 науқасқа рандомизацияланған зерттеу жүргізілді, соның ішінде негізгі топта – пентас препараты, бақылау тобында – стандартты протекторлық препараттар қолданылды. Пентас препаратын қабылдаған науқастарда сәулелік ем кезіндегі – ішек жағынан дамитын жағымсыз әсерлер төмен болуы, және де қосалқы жағымсыз әсерлердің дамуы байқалмаған. Негізгі топтың 13 науқасында (65%) және бақылау топтың 18 науқасында (95%) ішектің әр түрлі деңгейдегі токсикалық зақымдануы байқалған. Салыстырмалы қауіп (RR) - 0,72 95% ДИ (0,5-тен 1,03 дейін), ықтимал қатынасы – 0,21 95% ДИ (0,04-тен 1,16-ға дейін); пентас препаратын қолданғандағы ішектік асқынулардың дамуының абсолютты қауіпі 0,25-ке төмендеуі байқалған.

Түінді сөздер: сәулелік ем, өмір сапасы, кіші жамбас қуысының ісіктері.

Summary

V.B Kim., E.I Ishkinin., M.A. Ibraimova, Y.S. Malysheva, O.Y.Truschenko, R.G.Panov, R.D.Raimbekov. A.Sarsenbayev, r.Otyinshiyev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Application of Pentas in radiation therapy for Pelvic tumors patients

The issue of improving the quality of life and radiation therapy patients is increasingly important. A randomized study in 40 patients, with a core group of drug Pentas, the control group - a standard therapy. In the group treated with the severity of Pentas response from the intestine was lower not fixed additional side effects. At 13 study group patients (65%) and 18 control patients (95%) were recorded manifestations of toxic intestinal lesions in varying degrees. The relative risk (RR) was 0.72, 95% CI (0.5 to 1.03); odds ratio - 0.21, 95% CI (0.04 to 1.16) reduction in the absolute risk of intestinal complications on 0.25.

Key words: radiation therapy, quality of life, pelvic tumors, Pentas.